

Detoksykacja — *wskazania i przebieg*

Detoksykacja to medyczne odstawienie pod nadzorem lekarza. Nie jest leczeniem uzależnienia — jest jego bezpiecznym startem.

CZAS: 20 min czytanie Informacja przed konsultacją

ŹRÓDŁO: Mayo-Smith (1997, JAMA); NICE (2010); SAMHSA (2015)

JAK UŻYWAĆ

Karta wyjaśnia: 1) **czym jest detoksykacja** i czym nie jest, 2) **kiedy jest konieczna**, 3) jak wygląda **przebieg w warunkach szpitalnych**, 4) jakie **leki** się stosuje, 5) co po detoksie. Karta służy *orientacji* przed konsultacją z lekarzem — nie zastępuje rozmowy z nim. **Decyzję o detoksie zawsze podejmuje lekarz** na podstawie oceny stanu somatycznego i psychicznego pacjenta.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Mayo-Smith (1997, JAMA) i NICE (2010) ustalili standardy detoksu jako **medycznego protokołu** kontrolującego ryzyko śmierci w ciężkim odstawieniu. Bez nadzoru: śmiertelność *delirium tremens* (DT) wynosi 5–15%; z nowoczesnym leczeniem benzodiazepinami — < 1% (Mayo-Smith 1997). Świadomość pacjenta, na czym polega detoks: 1) zmniejsza lęk przed hospitalizacją („nie wiem, co mnie czeka”), 2) pomaga rozpoznać *kiedy* jest potrzebny, 3) uczy, że detoks to **punkt startowy**, nie wyleczenie — bez terapii po nim, 60–80% pacjentów wraca do używania w 6 miesięcy.

01 Czym jest detoks, a czym nie

CZYM JEST

- Medyczne zarządzanie objawami odstawiennymi
- Bezpieczne usunięcie substancji z organizmu
- Stabilizacja stanu somatycznego (elektrolity, wątroba)
- Podanie leków na drgawki, lęk, halucynacje
- Czas trwania: 5–14 dni (zwykle 7)
- Pierwszy etap drogi — nie cała droga

CZYM NIE JEST

- Leczeniem uzależnienia (to dopiero pole startowe)
- Gwarancją trzeźwości („wyjdę i nie wrócę”)
- Procedurą jednorazową (60–80% wraca bez dalszej terapii)
- „Kara” za picie / używanie
- Procedurą tylko dla najgorszych przypadków
- Konieczna we wszystkich uzależnieniach (np. marihuana często nie wymaga)

02 Kiedy detoks jest medycznie konieczny

 **Alkohol:** picie codziennie ≥ 6 standardowych drinków przez 6+ mies., wcześniejsze drgawki / DT, dolegliwości somatyczne (wątroba, serce)

 **Benzodiazepiny:** regularne używanie ≥ 3 mies., wysokie dawki, planowane szybkie odstawienie (zawsze stopniowe pod nadzorem)

 **Opioidy:** heroina, morfina, metadon, fentanyl — silne objawy fizyczne, ryzyko przedawkowania po odstawieniu

 **Wielosubstancjowe:** łączenie alkoholu + benzodiazepin / opioidów — bardzo wysokie ryzyko medyczne

 **Ciąża + uzależnienie** — konieczna konsultacja z ginekologiem i specjalistą uzależnień

 **Współistniejące choroby** — padaczka, choroby serca, wątroby; psychiczne (depresja z myślami samobójczymi)

03 Przebieg detoksu alkoholowego — typowe 7 dni

DZIEŃ	CO SIĘ DZIEJE FIZJOLOGICZNIE	CO DOSTAJE PACJENT	NASILENIE OBJAWÓW
1–2	Szczyt objawów odstawiennych: drżenia, pocenie, lęk, tachykardia, nudności	Benzodiazepiny (diazepam, oksazepam), nawodnienie, wit. B1 (zapobieganie encefalopatii Wernickego)	Silne, monitorowanie co 2 h
3–4	Szczyt ryzyka DT — halucynacje, dezorientacja, drgawki możliwe	Stopniowe zmniejszanie benzodiazepin, ew. neuroleptyki przy halucynacjach	Punkt krytyczny
5–7	Objawy somatyczne ustępują. Pojawia się <i>protrahowane odstawienie</i> : bezsenność, dysforia, anhedonia	Minimalna farmakologia. Rozpoczyna się psychoedukacja, planowanie dalszego leczenia	Stabilizacja

Po detoksie: protrahowane objawy (bezsenność, lęk, dysforia, anhedonia, niestabilność afektywna) mogą utrzymywać się **4–24 tygodnie**. To okres wysokiego ryzyka nawrotu — stąd konieczna kontynuacja w oddziale terapii lub poradni od razu po detoksie, bez przerwy.

04 Co po detoksie — plan kontynuacji

Detoks bez kontynuacji = nawrót w 60–80% przypadków w 6 miesięcy (Mayo-Smith 1997, NICE 2010). **Plan kontynuacji powinien być ustalony PRZED wyjściem ze szpitala:**

NASTĘPNA PLACÓWKA

— OTU stacjonarny lub poradnia ambulatoryjna

PIERWSZA GRUPA AA / NA

— data, miejsce

FARMAKOTERAPIA PODTRZYMUJĄCA

— np. naltrekson, akamprozat, ew. disulfiram

OSOBA ODBIERAJĄCA ZE SZPITALA

— ktoś świadomy planu, do kogo wracam

Klucz: Mayo-Smith (1997, JAMA) i NICE (2010) podkreślają: **detoks bez kontynuacji ma minimalną wartość terapeutyczną**. To jak operacja bez rehabilitacji — rana się goi, ale funkcja nie wraca. Pełna ścieżka: detoks (7 dni) → OTU stacjonarny (6–8 tyg.) lub intensywny program ambulatoryjny → poradnia podtrzymująca (12–18 mies.) → grupy AA bezterminowo + farmakoterapia. Stosowana w pełni — daje **50–60% trwałej abstynencji** w 5-letniej obserwacji (ang. *follow-up*). Wycinkowo — zwykle prowadzi do nawrotów.